

Fecha Última Actualización: 14-09-2022 14:25:51

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Jose Mauricio Villalobos Arias
Edad : 47a 1m 10d
Dirección : Quilacoya 085 Dpto. 24

Rut : 12.134.996-5
Fecha Nacto: 04/08/1975
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A020137
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 5525 5704

N° Epicrisis
321808

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 26/06/2022 06:32

Días Estadía: 80

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 14/09/2022 14:23

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compomiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICINA INTERNA HSR
14/09/2022

Nombre: José Mauricio Villalobos Arias
Edad: 47 años
RUN: 12.134.996-5
FI HSR: 26/06/22
FI Recu: 26/06/22
FI UCI: 01/07/22
FI UTIM: 04/09/22
FI Sala Medicina: 08/09/22

ANTECEDENTES

·Médicos: HTA, DM IR con DOB (retinopatía, obs. nefropatía), amaurosis izquierda
·Quirúrgicos: Desconoce
·Fármacos: Losartán 50mg c/12h, Atenolol 50mg/d, Furosemida 20mg/d, Amlodipino 20mgc/12h, Atorvastatina 20mg/d, Bicarbonato 1g c/8h, Insulina NPH 18-8
·Alergias: Se desconoce
·Hábitos: tabaco suspendido hace 10 años, OH (+) 1 cerveza/semanal, drogas THC
·Sociales: Jubilado por amaurosis izquierda. Vive con su madre y pareja de ella
MOTIVO DE CONSULTA: Compromiso de conciencia

ANAMNESIS PRÓXIMA

Paciente con antecedentes descritos, traído por su madre el 26/06/2022 a UEA por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por CEG, postración y episodio de caída a nivel con incontinencia de esfínter, tetraparesia y conexión parcial con el medio, posterior a lo cual suma disnea.
A su ingreso destaca: taquipneico, saturando 90% MAF 10 L, afebril, en sopor superficial, CRT 3s, frío a distal, UMA +, cianosis distal, MP + reducido en hemitórax derecho, PBC derecha, PCR COVID positiva.

TAC TAP con apendicitis gangrenosa perforada asociado a abscesos + peritonitis difusa. Foco de neumopatía aspirativa LID.

Fecha Epicrisis : 14/09/2022 14:25

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 14-09-2022 14:25:51

Página 2 de 4

AngioTAC cerebro - cuello. Evaluado por Neurología, refiere múltiples infartos lacunares, que no explican el cuadro actual.

Se interpreta cuadro como Shock séptico de foco mixto abdominal + pulmonar asociado a FOM; requiere inicio de noradrenalina hasta 0.2 ug/kg/min, intubación y conexión a VMI AC/V bajo parámetros protectores, inicia Ceftriaxona. Ingresa a pabellón de urgencia, se realiza laparotomía media infraumbilical que describe peritonitis estercorácea, plastrón apendicular. Se realiza aseo, se toman cultivos y se instala drenaje tubular, posteriormente se rescata cultivo de líquido peritoneal positivo para E. coli (resistente a Cotri y sensibilidad intermedia a Ampicilina sulbactam) + E. faecalis MS. Egres a recuperación anestésica, en donde, inicialmente requiere sedación profunda y conexión a ventilación mecánica invasiva, con antibioticoterapia dirigida a foco abdominal con Ceftriaxona + Metronidazol, evoluciona de forma favorable, por lo que inicia disminución de sedación en proceso de destete de la ventilación mecánica. En lo renal, evolucionó con falla renal aguda sobre crónica, el 01/07/2022 se instaló catéter de hemodiálisis. En ese contexto ingresa a UCI para diagnóstico, monitorización y tratamiento.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UCI:

Shock séptico a foco abdominal, peritonitis por perforación de víscera hueca.

- Compatible con apendicitis aguda complicada
- Laparotomía exploradora, Aseo quirúrgico, drenaje y laparorrafia
- Falla orgánica múltiple
- No se encontró apéndice cecal ni su base en el ciego.
- Plastrón apendicular/ Peritonitis apendicular
- Falla renal aguda sobre crónica

Hemodiálisis aguda 01/07/2022

- Falla hemodinámica
- Falla neurológica

Neumonía basal derecha

- PCR SARS COV 2 positiva
- Obs, aspiración

Antecedentes: HTA, DM IR con DOB (retinopatía, obs. nefropatía), amaurosis izquierda

EXÁMENES

Laboratorio:

07/07: Hto 25.4 % Hb 8.3 GB 7490 PLQ 77000 Crea 3.29 BUN 106 P 3.1 pH 7.465 pCO2 32.8 HCO3 23.1 BE -0.7 FA 486GPT 21 GGT 852 AU 6.7 BT 2.41 BD 2.02 PCR 115 Alb 2.3 GOT 85 ELP 144/3.66/100

Microbiología:

HC 06/09: PSAE productor de carbapenemasas

IMÁGENES Y OTROS: En sección evolución.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS DURANTE ESTADÍA

1.Hemodinámico: febril, pero hemodinamia autosostenida, se mantiene taquicárdico peri 100x. Politransfudido. Con anemia severa y caída de Hb gradual, sin evidencia de sangrado. Última tx el 06/09. En LET, se suspenden VDO, no más transfusiones.

2. Respiratorio: Ventilación prolongada. TQT quirúrgica el 01/08. Primer intento de destete de VMI el 06/08, se reconecta a modos controlados el 16/08. Segundo destete el 02/09. Actualmente en filtro. Con abundantes secreciones respiratorias en VAS. No más conexión a VMI, mantiene kine (manejo de TQT) y BD. Si impresiona con disnea, iniciar BIC Fentanyl.

3.Infeccioso: Múltiples intercurrentes infecciosas:

- Shock séptico de foco abdominal por E. coli + E. faecalis a tratado con Ceftriaxona + Metronidazol + Ampicilina
- Infección por COVID 19, recibió Dexametasona por 3 días.
- NAVM por Stenotrophomonas maltophilia y Serratia marcescens a tratada con Cotrimoxazol, sin stock, se cambió a Ciprofloxacino
- Evoluciona con colección multiloculada organizada hidroaérea en la FID y colección laminar en la gotera parietocólica ipsilateral a sin posibilidad de manejo quirúrgico por alto riesgo, se trata con Imipenem

Fecha Epicrisis : 14/09/2022 14:25

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 14-09-2022 14:25:51

Página 3 de 4

-NAVM por Stenotrophomona maltophilia y Serratia marcescens tratada con NBZ con Amikacina, sin respuesta, se rota a Tazonam + Levofloxacin, éste último cambiado a Cotri EV por mala tolerancia oral
-ITU por C. albicans + NAVM por C. albicans + posible candidiasis invasora. BDG negativo, completa Fluconazol por 21 días
-08/08 nuevo shock séptico, manejado con Imipenem luego rota a Meropenem (por crisis TCG) + Vancomicina + Amikacina, mantuvo Fluconazol. Posteriormente se rescata CAET (+) S. maltophilia.
-Finalmente y en contexto de DRESS, queda sólo con Cotrimoxazol, el que también se suspende por persistencia de alteración de pruebas hepáticas. Sin antibiótico desde el 31/08.
Actualmente con bacteriemia por PSAE (HC 2 del 06/09), pendiente tipificación. Dado LET, se decide no tratar.
Mantener aislamiento de contacto estricto por portación del 05/09 positiva por PSAE VIM y E. faecium van B.

4. Quirúrgico: Peritonitis apendicular complicada con plastrón, evoluciona con colección hidroaérea con salida de pus desde orificio de drenaje, se mantuvo manejo conservador con antibiótico (por alto riesgo quirúrgico y sin ventana para punción por rx intervencional), controles con disminución de tamaño de colecciones. Sin cobertura antibiótica para colecciones, se desestima nueva imagen de control.

5. Neurológico: Del estudio neurológico, destaca:

- TAC cerebro: Múltiples infartos cerebrales en diferentes territorios cerebelosos bilateral en territorio de PICA y SUCA, ponto-mesencefálico izquierdo, pedúnculo-pontino izquierdo, infartos múltiples de territorio profundo (tálamos, lenticulo-capsulares), infarto frontal derecho, aparente infarto occipital izquierdo.
- EEG: Ocasional actividad epileptiforme interictal central
- RNM de cerebro: Múltiples lesiones de aspecto isquémico reciente supra e infratentoriales que sugieren un origen embólico. Alteración de la señal de la sustancia blanca supratentorial, en la regiones tálamo-ganglionares, a nivel pontino y cerebeloso bilateral, de aspecto secuelear. Ventriculomegalia supra e infratentorial de aspecto ex vacuo. Irregularidad del tercio medio de la arteria basilar, con estenosis de aproximadamente 60-70%, probablemente de origen ateromatoso.

Con fenitoína que se suspendió por DRESS, actualmente con Levetiracetam oral.

Se desestima continuar estudio de fuente embólica.

Evaluable por neurología: "Paciente con lesiones isquémicas que no explican el estado de mínima conciencia, con mal pronóstico funcional, de acuerdo con limitación del esfuerzo. SOS neurología"

Renal: Cursando AKI KDIGO 3 con requerimiento de TRR, instalación de CHD el 08/08, se dializó por última vez 07/08. Se decide no mas diálisis. Se retiró CHD

Nutricional: Con NPTC a 59 ml/h, se suspende.

Manejo: Crítico crónico, grave, mal pronóstico neurológico, se conversó con familiares (mamá y hermana), se decide limitación del esfuerzo terapéutico, por lo que se suspenden antibióticos y medidas invasivas, no más hemodiálisis ni nutrición parenteral. Se mantiene CVC por malos accesos venosos y eventual requerimiento de inicio de BIC de Fentanyl. Mantener FAE. Se privilegian medidas de confort.

EVOLUCIÓN DURANTE ESTADÍA EN SALA BÁSICA

En plan de traslado a Clínica de Familia para continuar manejo de fin de vida.

Evoluciona el 14/09 en malas condiciones generales, apneas de 1-2 minutos de duración, desaturación hasta 60% ambiental. Se intenta manejo con KNTR de rescate y aspiración de secreciones, sin resultado. Bradicardia hasta 40 lpm, perfusión límite. Se constata fallecimiento de paciente a las 13:08 hrs del 14/09/22. Paciente previamente en manejo de fin de vida. Se avisa a familiares.

Se entrega certificado de defunción.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. Adecuación del esfuerzo terapéutico
2. Shock séptico de foco abdominal
 - a. Apendicitis aguda complicada con perforación y peritonitis
 - b. Plastrón apendicular, no se logra identificar apéndice cecal ni base del ciego (26/06)
 - c. Colección hidroaérea no organizada en fosa iliaca derecha y pelvis en resolución
3. AVE isquémicos múltiples de etiología embólica ¿lluvia embólica
 - a. Síndrome convulsivo secundario
 - b. Estado de mínima conciencia

Fecha Epicrisis : 14/09/2022 14:25

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 14-09-2022 14:25:51

4. Múltiples intercorrientes infecciosas (descritas previamente)
5. Falla multiorgánica resuelta
 - a. Falla renal aguda sobre crónica
 - b. Falla hemodinámica resuelta
6. Neumonía basal derecha resuelta
7. DRESS (Se suspende ATB + anticonvulsivantes)

Dra. Vilches/Dr. Oksenberg

Diagnóstico de Egreso

Sepsis, no especificada -
Accidente vascular isquémico -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se constata fallecimiento de paciente a las 13:08 hrs del 14/09/22. Paciente previamente en manejo de fin de vida.
Se avisa a familiares.
Se entrega certificado de defunción.

Plan Post Alta

Se constata fallecimiento de paciente a las 13:08 hrs del 14/09/22. Paciente previamente en manejo de fin de vida.
Se avisa a familiares.
Se entrega certificado de defunción.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Sebastián Oksenberg Sharim
Médico Tratante (Staff)